11. 목덩이 / 눈목부위 진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 곽지혜

2025년 시험 13번 · 출제자 곽지혜

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

각 나이에 따른 경부 종물의 원인을 빈도 순으로 옳게 나열한 것으로 옳은 것은?

① 15세 이하 : 외상성 - 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성

② 15세 이하 : 염증성 - 선천성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 외상성

③ 16-40세 : 염증성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 선천성 - 외상성

④ 16-40세 : 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성 - 외상성

⑤ 41세 이상 : 악성 종양성 - 양성 종양성 - 염증성 - 선천성

정답 ⑤

경부 종물의 원인은 나이에 따라 빈도가 다르다. 15세 이하는 염증성 > 선천성 > 양성 종양 > 악성 종양 순이고, 16~40세도 염증성이 가장 흔하다. 40세 이상 성인은 종양성, 특히 악성(전이성 림프절 등)이 가장 흔하므로 성인의 지속되는 목덩이는 악성을 배제하는 것이 우선이다('80% 규칙': 갑상선 외 성인 경부 종물의 약 80%가 종양성, 그중 80%가 악성).

2025년 시험 44번 · 출제자 곽지혜

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

흔히 경부 종물로 오인되는 정상구조물이 아닌 것은?

① Lateral process of C2

② Carotid bulb

③ Greater horn of hyoid bone

④ Greater cornus of thyroid cartilage

⑤ Sublingual gland

정답 ⑤

경부 종물로 흔히 오인되는 정상 구조물은 경추 가로돌기(특히 C1 · C2 쪽), 경동맥구(carotid bulb), 설골 큰뿔, 갑상연골 위뿔(greater cornu), 하악각 · 유양돌기, 커진 내경정맥 등이다. 혀밑샘(sublingual gland)은 입안 바닥(구강저)에 있어 목에서 만져지는 종물로 오인되지 않는다.

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

52세 여자 환자가 좌측 측경부 종물을 주소로 내원하였다. 시행한 CT가 아래와 같을 때, 가장 먼저 시행할 검사는?



① 식도조영술
② 조영증강 MRI
③ 18 FDG-PET/CT
④ **초음파 유도하 세침흡인세포검사**
⑤ 구인두 조직검사

> **정답 ④**
> 성인의 측경부 종물은 악성(전이성 림프절 등)을 먼저 배제해야 하며, 영상에서 병변을 확인한 뒤 가장 먼저 하는 조직학적 검사는 초음파 유도하 세침흡인세포검사(FNAC)다. 덜 침습적이면서 진단 정확도가 높아 병변의 성격(낭종 · 염증 · 전이암 · 림프종 등)을 판단하고 다음 검사(원발 부위 찾기, MRI · PET-CT 등)를 정하는 기준이 된다.

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

22세 남성이 몇 달 전부터 양측 목 부위에 만져지는 멍울로 내원하였다. 처음에는 왼쪽 목에 1.5cm 크기의 무통성 림프절이 발견되었는데, 서서히 크기가 증가하였고 오른쪽 목에도 비슷한 멍울이 2개 생겼다. 최근 밤에 식은땀을 흘릴 정도로 땀이 나고 열이 나는 일이 잦았으며, 식욕 감소로 체중이 5kg 감소하였습니다. 환자는 경부 림프절 외에 별다른 증상은 없었다. 림프절들은 단단하면서도 약간 탄력이 있는 고무같은 (Rubbery) 느낌으로, 서로 뭉치지 않고 가동성은 양호하였다. 가장 의심되는 진단은 무엇일까?



① 결핵성 림프절염
② 전염성 단핵구증
③ 악성 림프종
④ 두경부암 전이
⑤ 키쿠치림프절염

정답 ③

젊은 성인에서 수개월 동안 서서히 커지는 양측 경부의 무통성 림프절, B증상(발열, 야간 발한, 6개월 내 10% 이상 체중감소 등), 고무처럼 탄력 있고(rubbery) 잘 움직이며 서로 뭉치지 않는 림프절은 악성 림프종(특히 호지킨 림프종)을 시사한다. 확진은 절제생검이다. 결핵성 림프절염은 서로 엉겨 붙고 누공을 만들 수 있으며, 전이암은 단단하고 고정되며, 전염성 단핵구증 · 키쿠치병은 압통성 림프절과 급성 경과가 많다.

2024년

2024년 시험 31번 · 출제자 이길준

5. 다음의 경부 종물 중 선천성 원인으로 보기 어려운 것은?

① Thyroglossal duct cyst
② 2nd branchial cleft anomaly
③ Venous malformation
④ Metastatic cervical lymphadenopathy
⑤ Cystic hygroma

> **정답 ④**
> 갑상설관낭종, 제2아가미틈새 기형, 정맥기형, 낭성 림프관종(cystic hygroma)은 모두 발생 과정의 이상으로 생기는 선천성 경부 종물이다. 전이성 경부 림프절병증은 두경부암 등의 악성 종양이 림프절로 퍼진 것이므로 선천성 원인이 아니다.

2024년 시험 33번 · 출제자 이길준

6. 타액선에 발생하는 종양 중 Warthin's tumor(와르틴 종양) 에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 악성 변이 확률이 높다.
② 악하선(submandibular gland)에 가장 호발한다.
③ 종양의 성장과 흡연은 무관하다.
④ 대표적인 선천성 타액선 종양이다.
⑤ 약 10%에서 양측에 발생한다.

> **정답 ⑤**
> 와르틴 종양(papillary cystadenoma lymphomatosum)은 거의 이하선(귀밑샘)에만 생기는 양성 종양으로, 약 10%에서 양측성 · 다발성으로 생기는 것이 특징이다. 흡연과 밀접한 관련이 있고, 악성 변이는 매우 드물며, 선천성 종양이 아니다. 악하선에서 가장 흔한 종양은 다형성 선종이다.

2023년 담당 이길준

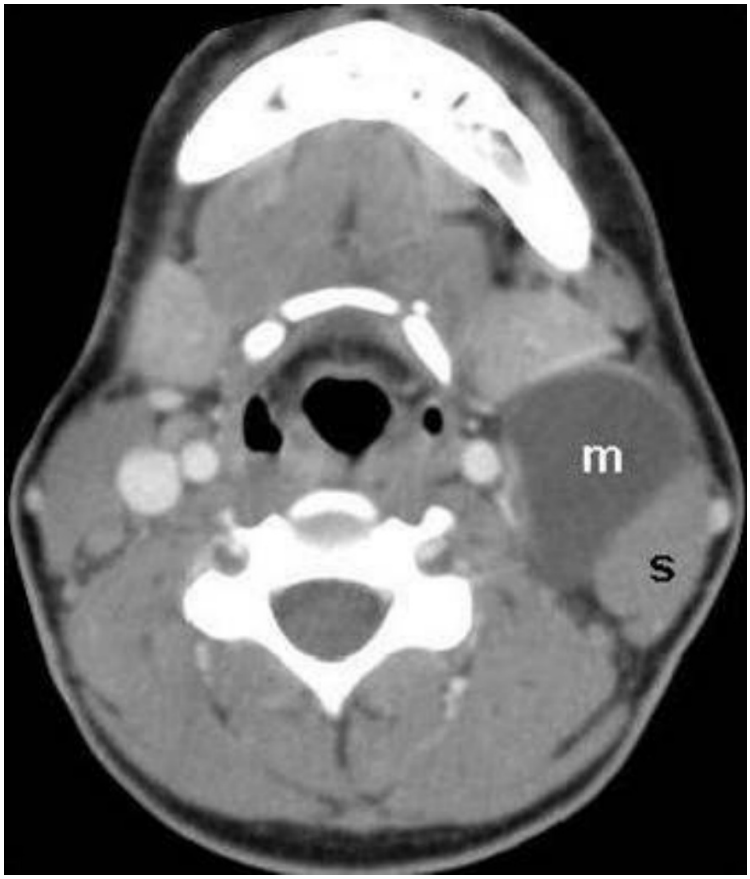
2023년 시험 13번

7. 침샘에 발생하는 다형성 선종에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 10%에서 양측성 종양으로 발생한다.
② 흡연과 밀접한 연관이 있다.
③ 15년 이상 지속되는 경우 악성 변이가 가능하여 수술적 치료가 필요하다.
④ 조직학적 병명은 papillary cystadenoma lymphomatosum 이다.
⑤ 세침흡인검사로는 진단이 불가하여 진단 시 총검생검을 시행한다.

> **정답 ③**
> 다형성 선종은 가장 흔한 침샘 양성 종양이지만 오래 방치하면 악성 변이(다형성 선종유래암종, carcinoma ex pleomorphic adenoma)의 위험이 커지므로(15년 이상 경과 시 약 10%) 수술적 절제가 원칙이다. 양측성 약 10%, 흡연 관련, papillary cystadenoma lymphomatosum이라는 병리명은 와르틴 종양에 대한 설명이다. 세침흡인검사로 대부분 진단할 수 있다.

8. 30세 남성이 좌측 턱 아래 부위에 수 년간 반복적으로 발생하는 부종으로 내원하였다. 통증이나 압통은 없었고 부종은 식이에 심해지는 양상도 아니었다. 시행한 경부 CT가 다음과 같을 때 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



① 유피 낭종과 감별해야 한다.
② 갑상선 기능검사를 시행한다.
③ 침을 삼키게 하였을 때 움직이는 것이 특징이다.
④ 생후 24개월 이후에 발생하는 것이 특징이다.
⑤ 구인두암 낭성 경부 전이 여부를 감별해야 한다.

정답 ⑤

젊은 성인의 턱 아래 · 측경부에 수년간 반복되는 무통성 낭성 종물로 CT에서 낭종이 보이면 제2아가미틈새 낭종을 가장 먼저 생각한다. 그러나 성인의 측경부 낭성 종물은 구인두암(특히 HPV 연관 편도 · 설근부암)의 낭성 림프절 전이일 수 있으므로 반드시 감별해야 한다. 유피낭종 · 갑상설관낭종은 정중선에 생기며, 갑상선 기능검사와 삼킬 때 움직임은 갑상설관낭종에 해당하는 설명이다.

9. 경부 임파선 구획 중 악하선(submandibular gland)이 속한 구획은 어디인가?

① Level I
② Level II
③ Level III
④ Level IV
⑤ Level V

정답 ①

경부 림프절 구획 중 Level I은 턱밑 부위로, IA는 턱끝밑 삼각(submental), IB는 턱밑 삼각(submandibular)이며 악하선(턱밑샘)은 Level IB에 위치한다. Level II~IV는 내경정맥을 따라 위 · 중간 · 아래 부분, Level V는 후경삼각이다.

원본 오답노트

cervical LN 구획 I - VII 중 Level I 그 중 level IB 에 속한다.

10. 14개월 남아가 울때마다 우측 턱 밑이 붓는다는 증상을 주소로 내원하였다. 촉진 시 부드럽고 힘을 주면 들어가는 양상이었다. 최근 감기 등 감염의 병력은 없었으며 내원 당시 열이나 기침 가래, 소변량 감소 등 영유아에서 흔한 감염 의심 소견도 없었다. 다음 사진과 같은 양상일 때 의심할 수 있는 질환은 무엇인가?

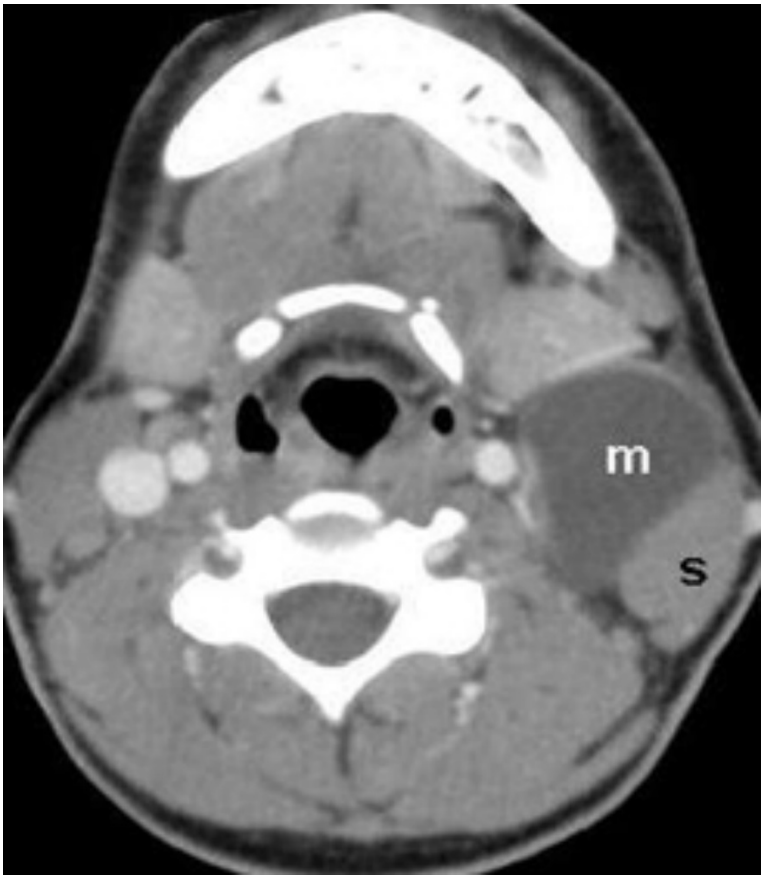


① Submandibular gland stone
② Venous malformation
③ Thyroglossal duct cyst
④ Tuberculosis
⑤ Kikuchi disease

> **정답 ②**
> 울거나 힘을 줄 때(정맥압 상승) 커지고, 만지면 부드럽고 눌러서 들어가며(압축성), 감염 소견이 없는 소아의 턱 밑 종물은 정맥기형(venous malformation)의 특징이다. 피부가 푸르스름하게 보이기도 한다. 침샘 결석은 식사할 때 붓고 아프며, 갑상설관낭종은 정중선 종물로 삼킬 때 움직이고, 결핵 · 키쿠치병은 림프절 비대다.

2022년 시험 25번

11. 20세 남성이 4개월간 지속된 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 압통이나 통증은 없었으며 최근 1달 사이에 크기가 약간 감소하였다고 하였다. CT 소견이 다음과 같을때 감별해야 할 질환으로 가장 연관성이 낮은 것을 고르시오



① Branchial cleft cyst
② lymphangioma
③ Plunging ranula
④ Thyroglossal duct cyst (TGDC)
⑤ Cystic hygroma

정답 ④

젊은 성인의 측경부 낭성 종물은 제2아가미틈새 낭종, 림프관종(낭성 림프관종 cystic hygroma), 함몰 하마종(plunging ranula; 구강저에서 악하부로 내려온 침 저류낭종) 등을 감별해야 한다. 갑상설관낭종(TGDC)은 목의 정중앙(설골 부근)에 생기는 선천성 종물이므로 측경부 병변과는 연관성이 가장 낮다.

원본 오답노트

TGDC 는 정중앙 부위에 발생하는 선천성 종물

12. 결핵성 임파선염에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 우리나라의 결핵 발생율은 폐결핵보다 경부임파선결핵의 발생율이 더 높다.
② 경부임파선결핵의 표준치료는 수술적 절제이다.
③ 절제생검(excisional biopsy)보다 PCR 검사의 진단율이 더 높다.
④ 첫 진단 시 10일간의 격리 과정이 필요하다.
⑤ Chest X-ray 로 폐결핵의 유무를 반드시 평가해야 한다.

> **정답 ⑤**
> 경부 림프절결핵이 진단되면 활동성 폐결핵이 동반되었는지(전염성 판단과 치료 계획) 반드시 흉부 X선으로 확인해야 한다. 우리나라에서는 폐결핵이 경부 림프절결핵보다 훨씬 흔하고, 표준치료는 수술이 아닌 항결핵제 복용이며, 진단율은 PCR보다 절제생검(조직학적 육아종 · 배양)이 더 높다. 격리는 전염성 폐결핵이 있을 때 필요하다.

13. 45세 남성이 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 후두 내시경 상 구인두 및 후두의 특이 소견은 관찰되지 않았다. 경부 CT 를 시행하였고 좌측 경부의 병변에 대해 세포 검사를 시행하였으며 악성(malignancy)으로 진단되었다. 감별해야 할 질환으로 가장 적절하지 않을 것을 고르시오



① 편도선암(Tonsil cancer)
② 원발부위 상세불명 전이암(MUO)
③ 설근부암(Tongue base cancer)
④ 갑상선암(Thyroid cancer)
⑤ 하인두암(Hypopharyngeal cancer)

정답 ⑤

후두 내시경이 정상인 성인의 Level II 낭성 전이 림프절은 원발 부위로 구인두암(편도 · 설근부, 흔히 HPV 연관), 비인두암, 갑상선 유두암, 원발 부위 불명 전이암(MUO)을 감별한다. 하인두암은 후두 내시경 검사에서 보이는 경우가 많고 낭성 전이를 잘 만들지 않으므로 감별 대상으로 가장 적절하지 않다.

원본 오답노트

Cystic metastasis , level II
로 구인두암 및 비인두암, 갑상선암,
MUO 등이 감별진단의 대상이다.

2022년 시험 84번

14. 침샘종양(Salivary gland tumor)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 악하선(Submandibular gland)에 가장 호발하는 종양은 Warthin's tumor 이다.
② 이하선 종양 환자에서 안면신경 마비가 동반되었다면 악성 종양일 가능성이 높다.
③ 다형성 선종(Pleomorphic adenoma)은 악성화 변이 가능성이 낮다.
④ 소타액선(Minor salivary gland)에는 종양이 발생하지 않는다.
⑤ 침샘 종양의 진단에 세포검사보다 PET CT 를 활용한 검사의 활용도가 더 높다.

> **정답 ②**
> 이하선 종양에서 안면신경 마비가 동반되면 신경 침범을 의미하므로 악성 종양일 가능성이 높다. 악하선에서 가장 흔한 종양은 다형성 선종이고(와르틴 종양은 거의 이하선에만 생김), 다형성 선종은 오래 두면 악성 변이가 생길 수 있으며, 소타액선에도 종양이 생기고 오히려 악성 비율이 높다. 침샘 종양 진단의 기본은 세포검사(세침흡인)다.

2021년

2021년 시험 10번

15. 목덩이(neck mass) 가 의심되어 내원한 환자에 대한 감별 진단 중 성격이 다른 하나를 고르시오

① Torus mandibularis
② Thyroid notch
③ Mastoid tip
④ Branchial cleft cyst
⑤ Enlarged internal jugular vein

> **정답 ④**
> 하악 융기(torus mandibularis), 갑상연골 절흔(thyroid notch), 유양돌기 끝(mastoid tip), 커진 내경정맥은 모두 목덩이로 오인될 수 있는 정상 구조물이다. 아가미틈새 낭종(branchial cleft cyst)은 실제 질환(선천성 낭종)이라는 점에서 성격이 다르다.

2021년 시험 43번

16. 일반적으로 목덩이에 대한 신체검진 상 악성종양(malignant tumor)이 의심되는 경우가 아닌 것은?

① 급격하게 자라는 종물
② 딱딱하게 만져지는 종물
③ 2cm 이상의 표면이 거친 단일 종물
④ 주변 조직과 유착되어 고정되어 있는 종물
⑤ 크기가 커졌다가 작아지는 종물

> **정답 ⑤**
> 악성을 시사하는 목덩이 소견은 빠르게 자람, 딱딱함, 크기가 큼(2~3 cm 이상), 표면이 불규칙함, 주변 조직과 유착되어 고정됨, 통증 없음, 고령 · 흡연 · 음주 병력 등이다. 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 종물은 염증성(반응성 림프절, 침샘염 등)이나 낭종을 시사한다.

17. 21세 여성이 1년전부터 목 정중앙 부위에 만져지는 종물로 내원하였다. 크기 변화나 통증 압통 등의 양상은 보이지 않았다고 하였으며 미용 상 수술적 제거를 원한다고 하였다. 신체 검진 상 목 정중앙 부위에 1cm 가량의 표면이 매끄러운 종물이 촉지되었고 침을 삼켰을때 종물의 위아래로 움직이는 것을 확인하였다. 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



① Dermoid cyst(유피낭종)와 감별해야 한다.

② Hyoid bone(설골)을 보존하는 Sistrunk operation이 필요하다.

③ 경부 외상이 대표적인 발생 원인이다.

④ 목의 정중앙에 위치한 관계로 세침흡인검사와 같은 침습적 검사는 금기이다.

⑤ 악성종양과는 무관하다.

정답 ①

목 정중앙의 매끄러운 종물이 삼킬 때(또는 혀를 내밀 때) 위아래로 움직이면 갑상설관낭종이다. 같은 정중선에 생기는 유피낭종과 감별해야 한다(유피낭종은 혀를 내밀어도 움직이지 않음). Sistrunk 수술은 재발을 막기 위해 설골 중앙부를 함께 절제하고, 원인은 선천성(갑상선 하강 경로의 잔존)이며, 세침흡인검사는 가능하고, 드물게(약 1%) 갑상선 유두암이 생길 수 있다.

18. 하악 측면 주변 level II 구역에 발생한 낭성 종물(cystic lesion)에서 metastatic malignant cell(악성전이세포)이 확인되었다. 원발 부위로 가능성이 낮은 것을 고르시오

① palatine tonsil
② Base of tongue
③ Soft palate
④ Thyroid
⑤ Liver

> **정답 ⑤**
>
> Level II의 낭성 전이 림프절은 구인두(구개편도, 설근부, 연구개)암, 특히 HPV 연관 암에서 흔하며, 갑상선 유두암과 비인두암도 낭성 전이를 만든다. 간은 두경부 림프절, 그것도 Level II로 전이하는 경로가 아니므로 원발 부위로 가능성이 낮다 (복부 장기 암은 왼쪽 쇄골위 Virchow 림프절로 전이할 수 있음).

2020년

2020년 시험 47번

19. 다음 설명으로 옳은 것을 고르시오

16세 남아가 2개월 간 지속된 양측 경부의 무통성 다발성 종괴로 내원하였다. 상기도 감염 병력은 없었고 기타 기저질환의 병력도 없었다. 2개월 간 종물의 크기 변화는 없었으며 외래에서 시행한 신체 검진 상 양측 경부의 전반적으로 분포하고 있었고 크기는 1-2cm 정도의 크기였고 압통은 없었다. 경부 CT 를 시행하였고 그림에서와 같은 소견이었다. 이 환아에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 절개생검(Incisional biopsy)은 절대 금기이다.

② 2주 간의 결핵약 복용이 필요하다.

③ 세침흡인검사로 90% 이상 진단이 가능하다.

④ **내시경을 통해 비강, 비인두, 구인두의 병변 여부를 확인해야 한다.**

⑤ 70% 이상에서 leukopenia(백혈구감소증)를 동반한다.

정답 ④

10대 남아의 양측 경부에 전반적으로 분포하는 무통성 다발성 림프절이 2개월 이상 지속되고, CT에서 조영증강이 약한 균질한 둥근 림프절이 여러 개 보이면 림프종을 의심하며 결핵 · 키쿠치병과 감별한다. 이때 비강 · 비인두 · 구인두(Waldeyer 고리)에 원발 병변(비인두암, 림프종)이 있는지 내시경으로 확인해야 한다. 림프종 진단에는 세침흡인으로 부족하고 절제(절개)생검이 필요하며, 진단 없이 결핵약을 먹이지 않는다.

원본 오답노트

CT 상 조영이 잘 되지 않는 homogenous round shape 의 multiple LN 들이 있는 소견으로 lymphoma 를 의심할 수 있다.
TB Kikuchi Dz 등과 감별이 필요하다.

2020년 시험 48번

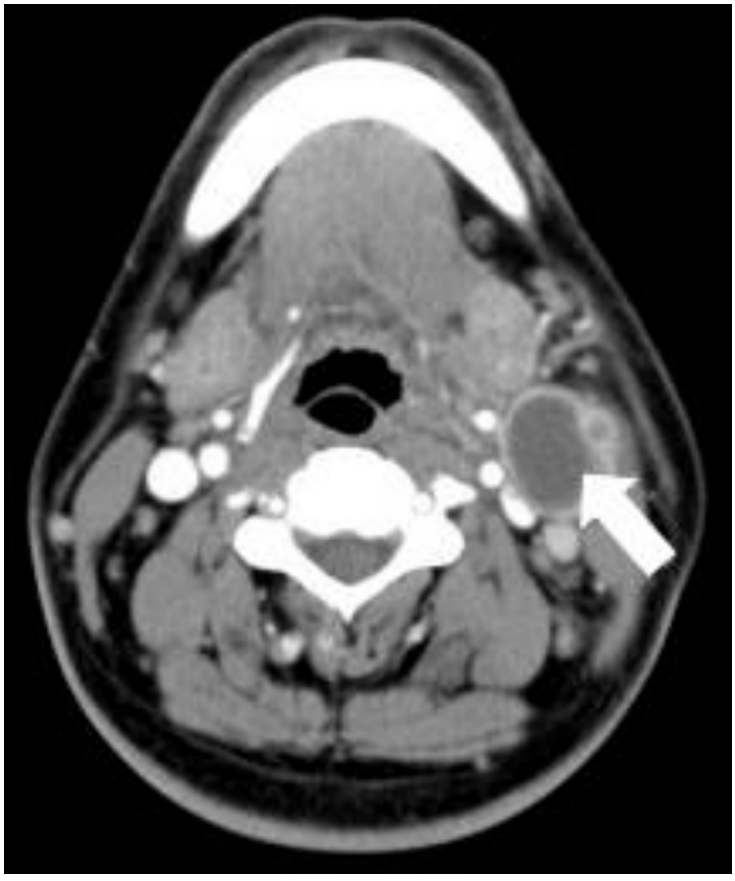
20. 경부 종물(neck mass) 에 대한 진단적 접근에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 통증과 압통을 동반하며 종물의 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 양상이라면 악성 종양을 우선 의심한다.
② 종물이 고정(Fixation) 되어 있는 양상이라면 선천성 종물의 가능성이 많다.
③ 우리나라(대한민국) 40대 이상 남성에서 경부 종물의 가장 흔한 원인은 결핵이다.
④ 소아에서 경부 정중선 부근의 종물은 갑상설관낭종(thyroglossal duct cyst) 의 가능성이 많다.
⑤ 림프관종(lymphangioma)은 선천성 기형의 일종으로 40대 이후 성인에서는 발병하지 않는다.

> **정답 ④**
> 소아의 경부 정중선 부근 종물은 갑상설관낭종이 가장 흔하다(삼킬 때 · 혀를 내밀 때 움직임). 통증 · 압통이 있고 크기가 변하면 염증성을, 고정된 종물은 악성을 시사한다. 우리나라 40대 이상 남성의 경부 종물은 전이암 등 악성 종양이 가장 흔하며, 림프관종은 대부분 소아에서 발견되지만 드물게 성인에서도 나타날 수 있다.

2020년 시험 49번

21. 42세 남성이 수개월 간 지속된 좌측 악하부 종물을 주소로 내원하였다. 흡연 음주력은 없었고 특이한 기저질환도 없었다. 종물은 무통성의 부드러운 낭종 양상으로 단일 종물이었으며 내시경 및 세침흡인검사와 경부 CT 를 시행하였다. 내시경 상 구인두, 비인두, 후두, 하인두의 특이 병변은 없었으며 세침흡인검사 상 metastatic carcinoma 소견이었고 CT 는 다음 그림과 같았다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① HPV(human papilloma virus) 검사를 시행해야 한다.
② 전신마취 하 강직성 후두경을 통해 하인두(hypopharynx)에 대한 무작위 조직검사가 필수적이다.
③ CT 상 보이는 병변에 대한 절개 및 배농(Incision and drainage) 후 cytology(세포검사) 를 시행한다.
④ Branchial cleft cyst(BCC) 기원의 악성 종양 가능성이 높으며 예후는 불량할 것으로 예측된다.
⑤ 항암요법은 치료 효과가 미미할 것으로 예측된다.

정답 ①

비흡연 · 비음주 성인에서 내시경상 원발 병변이 보이지 않는 악하부(Level II)의 낭성 전이암은 HPV 연관 구인두암(편도 · 설근부)의 낭성 림프절 전이를 가장 먼저 의심하므로 HPV(p16) 검사를 시행한다. HPV 연관 구인두암은 항암방사선 치료 반응이 좋고 예후도 좋다. 원발 부위 탐색은 구인두가 우선이며 PET-CT가 도움이 되고, 전이암이 의심되는 낭종의 절개 · 배농은 금기다. 아가미틈새 낭종에서 생긴 암은 매우 드물다.

원본 오답노트

oropharngeal ca 의 cystic meta 가 의심되는 상황으로 환자가 비흡연자라는 점에서
HPV origin 을 추정할 수 있다.
HPV associated OPHx ca 의 경우 예후는 좋으며 chemoradiation 에 대한 반응이
우수하다.
보기 2 : oropharynx 가 가장 가능성이 높으며 최근에는 PET CT 로 진단이 가능한 경
우가 많다.
보기 3: I&
D 는 금기
보기 4: BCC carcinoma 는 매우 드물며 상기 CT 사진은 BCC 와 cystic meta 를 감별
하는 것이 중요
보기 5 항암치료는 매우 효과적일 것으로 예측

2020년 시험 50번

22. 경부 종물로 오인하기 쉬운 정상 구조물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 설골(hyoid bone)은 갑상연골(thyroid cartilage) 하부에 위치한다.

② Carotid bulb 는 내외 분지가 분리되는 곳으로 cervical level IV 와 V 의 경계가 되는 구조물이다.

③ Mandible angle (하악각) 과 mastoid tip(유양돌기) 사이에 위치하는 침샘은 이하선(parotid gland)이다

④ 갑상연골(thyroid cartilage)은 원형으로 360도 모두 연골로 구성되어 있다.

⑤ 정상 성인에서 cervical spine (경추)은 촉지되지 않는다.

정답 ③

하악각과 유양돌기 끝 사이, 귀 앞아래에 있는 침샘은 이하선(귀밑샘)이다. 설골은 갑상연골 위쪽에 있고, 경동맥구는 Level II와 III의 경계에 해당하며, 갑상연골은 뒤쪽이 열린 방패 모양이다(360도 고리 모양 연골은 윤상연골). 경추의 가로돌기는 정상 성인에서도 목 옆에서 만져질 수 있다.

원본 오답노트

1. 설골은 갑상연골 상부에 위치
2. level II III 의 경계
4. cricoid cartilage 에 대한 설명